

# conversacion\_2

---

Fecha y hora: 2026-04-15 12:59:34

Paciente: [Speaker 2]

Diagnóstico:

## Antecedentes diagnósticos:

---

### 1. Antecedentes médicos:

- Otitis en la infancia (infección de oído) sin secuelas actuales referidas.
- Resfriado común reciente.
- No refiere episodios previos de parálisis facial.
- Refiere hipoacusia progresiva en los últimos meses (familia sugiere uso de audífono).
- Estilo de vida: recién jubilado; niega estrés reciente.

### 2. Antecedentes de medicación: Insertar más información aquí

## Subjetivo:

---

- Motivo de consulta: dificultad para mover la mitad derecha de la cara desde hace ~3 meses (inicio alrededor de Navidades).
- Síntomas asociados: dificultad para hablar, sonreír y cerrar el ojo derecho.
- Evolución: inicio insidioso y progresivo.
- Niega otalgia y otorrea en los últimos meses.
- Niega infecciones recientes distintas al catarro; niega herpes zóster o varicela recientes.
- Niega exposición al frío previa al inicio.
- Refiere disminución de la audición en los últimos meses.

## Objetivo:

---

- Se planea iniciar exploración física (sin hallazgos objetivos documentados aún en la transcripción).
- No se aportan resultados de laboratorio ni de imagen en la transcripción.

## Diagnóstico principal:

---

- Valoración: Parálisis facial periférica derecha de curso subagudo/progresivo (considerar parálisis de Bell vs otras etiologías: patología del oído medio/interno, neuropatía compresiva, enfermedad inflamatoria o infecciosa; la hipoacusia asociada obliga a descartar afectación del VIII par o patología del ángulo pontocerebeloso).
- Diagnóstico sospechoso: Ninguno por el momento

## Plan:

---

- Prescripción: Insertar más información aquí
- Próximos pasos/exámenes:
  - Exploración neurológica completa de pares craneales, con énfasis en VII par (asimetría facial, cierre palpebral, signo de Bell) y diferenciación central vs periférica.
  - Otoscopia y exploración ORL para descartar patología del oído medio y externo.
  - Audiometría tonal y logaudiometría para cuantificar la hipoacusia; considerar potenciales evocados auditivos si procede.
  - Considerar serologías y pruebas según contexto (p. ej., VIH, Lyme según epidemiología, VZV si hay sospecha).
  - Considerar RM de ángulo pontocerebeloso y trayecto VII–VIII si hipoacusia/progresión o signos atípicos, para descartar neurinoma del acústico u otras lesiones.
  - Valorar medidas de protección ocular si hay lagofthalmos (lágrimas artificiales, pomada oftálmica nocturna, oclusión nocturna).
- Plan de tratamiento y seguimiento:
  - Revisión en consulta tras resultados de audiometría y, si procede, de neuroimagen.
  - Según hallazgos: considerar corticoides orales si se confirma parálisis de Bell en ventana adecuada; antivirales solo si sospecha de etiología herpética.
  - Educación sobre cuidados oculares para prevenir queratitis por exposición.
  - Derivación a rehabilitación/fisioterapia facial si persisten déficits.
  - Ajuste terapéutico según evolución clínica y resultados de pruebas complementarias.

